UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

NEPRHOLOGIE
Compte rendu de biopsie rénale
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : KUCHTA Alicia **Date de rédaction : 3/01/24**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 180– Interprétation d'un compte rendu anapath

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)): **NON PRECISES DANS LE LISA !**

Patient simulé nécessaire à la station : NON

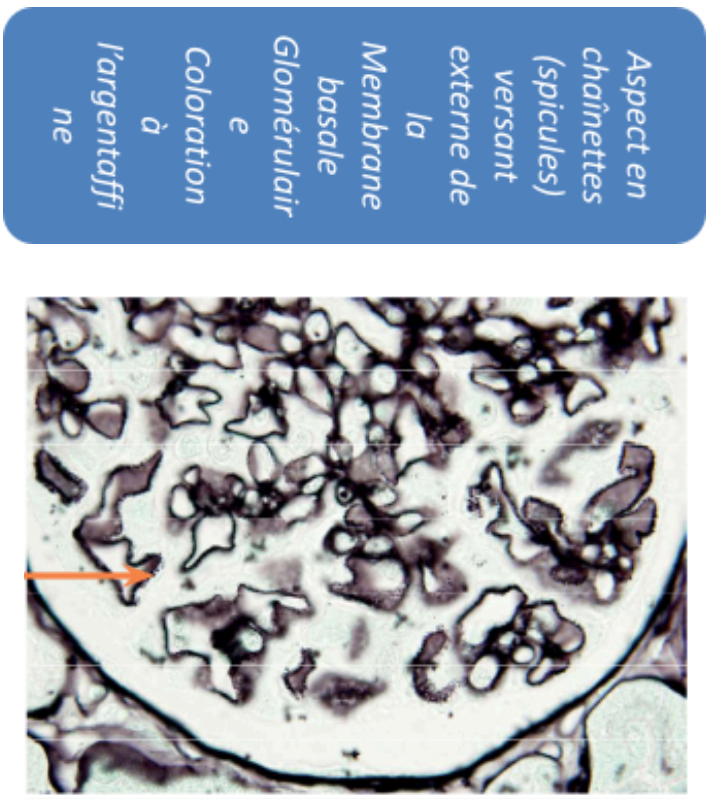
Matériel nécessaire à la station

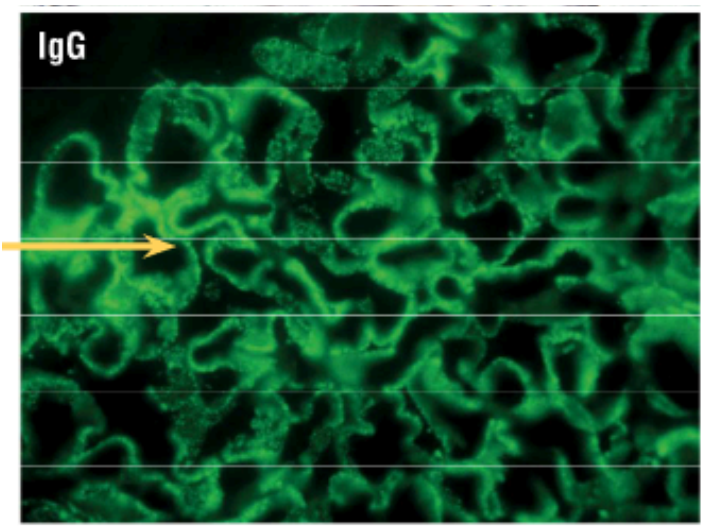
- Mannequin NON
- Brancard NON
- Fournir à l'étudiant les photos des lésions cutanées présentées par la patiente et le compte rendu anapath

Lésions cutanées présentées par la patiente à la consultation

TUT'ECOS

Fournir à l'étudiant le compte rendu de la biopsie rénale dont les images sont déjà interprétées :





« En microscopie optique, les tubes, l'interstitium et les vaisseaux sont normaux. Les glomérules sont indemnes de prolifération. La membrane basale glomérulaire paraît épaissie. L'examen en immunofluorescence met en évidence des dépôts d'IgG et de C3 granuleux le long de la membrane basale glomérulaire »

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne de néphrologie à Pasteur. Vous recevez à la consultation Mme Rein 32ans, avec les résultats de sa biopsie rénale faite dans un contexte de protéinurie (4g/j). A la consultation celle-ci présentait des arthralgies bilatérales et symétriques et diverses lésions cutanées.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Identifier la néphropathie glomérulaire. Classer son stade

   (il n'est pas attendu de vous de décrire les lésions cutanés)

2. Expliquer à la patiente votre diagnostic et la suite de la prise en charge (traitements, mesures associées, pécautions pour prévenir une poussée)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Identifie la néphropathie glomérulaire : « Glomérulopathie extra membraneuse secondaire à une néphropathie lupique »	
Enonce le stade de la néphropathie lupique : Stade V	
Tache 2	
Envisage **un traitement de fond** d'une **forme mineure** cutanéo-articulaire **: hydroxychloroquine** (PLAQUENIL)+/- **corticoïdes** faible posologie pour contrôler et prévenir les rechutes	
Enonce le traitement **symptomatique** : atteinte articulaire : **AINS** Atteinte cutanée : **dermocorticoïdes**	
Enonce les **précautions** à prendre quant à l'utilisation d'hydroxychloroquine : Réalisation d'un **fond d'œil** à la recherche d'une rétinopathie	
Enonce **les facteurs déclenchant**s une poussée : exposition solaire, œstrogènes, grossesse, certaines infections (point si ¾)	
Dit qu'il faut faire une Déclaration en **ALD** 30, car maladie chronique	
Identifie le lien possible entre poussée et œstrogènes : dit qu'il faudra envisager **une contraception sans œstrogènes** *: **DIU, ou progestérone PO***	
Dit qu'il est important de **programmer et d'encadrer les grossesses** pour prévenir des poussées lors de la grossesse et de l'accouchement	
Prévention des complications de **l'immunodépression : traitement des foyers infectieux, vaccination pneumocoque, grippe COVID**	
Prévention des complications de la corticothérapie prolongée : **régime désodé**, diminuer la **consommation de sucres rapides**, corriger une carence en **vitamine D** et une éventuelle **hypocalcémie par calcium**	
Enonce l'importance de prendre en charge **les facteurs de risques cardiovasculaires** (HTA, tabac, dyslipidémie)	
Evoque quelques complications possibles du lupus : **poussées incontrôlées, athérosclérose** accélérée avec thromboses plus fréquentes en partie liée aux corticoïdes**, infections, cancers**	
Dit qu'il faudra envisager une prise en **charge pluridisciplinaire**, avec **un suivi régulier** pour contrôler au mieux les poussées et prévenir les complication	
Evoque la possibilité de la mise en place **d'un soutien psychologique** dans le cadre d'une maladie chronique	
COMPETENCES GENERIQUES	
Est capable d'établir des priorités dans ses activités de soins et de formation et de les justifier	1 à 5
Aptitude à faire la synthèse des données	

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Identifie la néphropathie glomérulaire : « Glomérulopathie extra membraneuse secondaire à une néphropathie lupique »	3 si totalité 2 si GEM ou néphropathie lupique 1 si lupus
Enonce le stade de la néphropathie lupique : Stade V	3
Tache 2	
Envisage **un traitement de fond** d'une **forme mineure** cutanéo-articulaire **: hydroxychloroquine** (PLAQUENIL)+/- **corticoïdes** faible posologie pour contrôler et prévenir les rechutes	3
Enonce le traitement **symptomatique** : atteinte articulaire : **AINS** Atteinte cutanée : **dermocorticoïdes**	2
Enonce les **précautions** à prendre quant à l'utilisation d'hydroxychloroquine : Réalisation d'un **fond d'œil** à la recherche d'une rétinopathie	2
Enonce **les facteurs déclenchant**s une poussée : exposition solaire, œstrogènes, grossesse, certaines infections (point si ¾)	3
Dit qu'il faut faire une Déclaration en **ALD** 30, car maladie chronique	2
Identifie le lien possible entre poussée et œstrogènes : dit qu'il faudra envisager **une contraception sans œstrogènes** *: **DIU, ou progestérone PO***	2
Dit qu'il est important de **programmer et d'encadrer les grossesses** pour prévenir des poussées lors de la grossesse et de l'accouchement	2
Prévention des complications de **l'immunodépression : traitement des foyers infectieux, vaccination pneumocoque, grippe COVID**	5
Prévention des complications de la corticothérapie prolongée : **régime désodé**, diminuer la **consommation de sucres rapides**, corriger une carence en **vitamine D** et une éventuelle **hypocalcémie par calcium**	5
Enonce l'importance de prendre en charge **les facteurs de risques cardiovasculaires** (HTA, tabac, dyslipidémie)	5
Evoque quelques complications possibles du lupus : **poussées incontrôlées, athérosclérose** accélérée avec thromboses plus fréquentes en partie liée aux corticoïdes**, infections, cancers**	5
Dit qu'il faudra envisager une prise en **charge pluridisciplinaire**, avec **un suivi régulier** pour contrôler au mieux les poussées et prévenir les complication	2
Evoque la possibilité de la mise en place **d'un soutien psychologique** dans le cadre d'une maladie chronique	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Est capable d'établir des priorités dans ses activités de soins et de formation et de les justifier	2

Aptitude à faire la synthèse des données	2

/50